

LEISHMANIASIS

Victoria B. Muñoz Embuena, Saray Suárez García, Paula Dios Díez.

INTRODUCCIÓN

La leishmaniasis (o leishmaniosis) es causada por un protozoo parásito del género *Leishmania*. Es una enfermedad de evolución crónica que puede afectar la piel, mucosas y vísceras, dependiendo de la especie que causa la leishmaniasis y de la respuesta del sistema inmunológico del paciente, manteniendo en común entre ellas: el agente causal (la *Leishmania*), el vector (insectos dípteros hematófagos), el reservorio (vertebrados) y el parasitismo del sistema fagocítico mononuclear (macrófagos). Es transmitido al humano por la picadura de la mosca hembra de la arena de la familia de los flebotominos, tras haber estado en contacto con un hospedero reservorio infectado. El género *Leishmania* comprende alrededor de 30 especies, con al menos 20 de ellas patógenas para el humano.

Los reservorios son animales vertebrados, principalmente mamíferos, y pueden ser domésticos o silvestres. El reservorio doméstico más importante para *L. infantum* es el perro.

Forma parte de la lista de enfermedades tropicales desatendidas de la OMS.

Manifestaciones clínicas

Clínicamente se manifiesta de tres formas principales: cutánea, mucosa y visceral.

Leishmaniasis cutánea

L. infantum es la causa más frecuente de leishmaniasis cutánea en nuestro medio. Puede presentarse como una o varias lesiones en la piel. Puede tener la apariencia de nódulo, placa, con descamación epidérmica, o de una úlcera. Inicialmente, la úlcera está cubierta por una costra muy bien adherida al fondo; al desprenderse la costra se observa una úlcera franca conocida como el “botón de Oriente”, de fondo limpio, color rosado, redondeada, de bordes regulares y levantados, indolora y de base indurada. En ocasiones, la úlcera se sobreinfecta con bacterias y dan lugar a úlceras piógenas. Desde los primeros síntomas de la leishmaniasis cutánea, los parásitos invaden los cordones y los ganglios linfáticos y producen linfadenopatías regionales.

Leishmaniasis mucosa

Se presenta sobre todo en América Latina cuando leishmanias del subgénero *Viannia* se diseminan por vía linfática y sanguínea desde una lesión cutánea e invaden las mucosas de la región nasoorofaríngea. La invasión del parásito a la mucosa se observa inicialmente como una hiperemia con congestión nasal, que evoluciona a la formación de nódulos semejante a granos de arroz que confluyen; posteriormente aparece una úlcera y luego se perfora el tabique. El daño continúa con invasión y destrucción de tejidos contiguos como el paladar blando y duro, labios, faringe, laringe y tráquea. La evolución de las lesiones en mucosas es muy crónica y pueden persistir durante años; tienen pobre respuesta al tratamiento con antimoniales pentavalentes, por lo que las recaídas son frecuentes. Se hace evidente la destrucción de estructuras cartilaginosas.

Leishmaniasis visceral “Kala-azar”

Es la forma sistémica de la enfermedad causada por el complejo *L. donovani*–*L. infantum*, en la cual, tras la multiplicación del parásito en la piel, que puede causar o no una lesión pequeña transitoria, los parásitos y los macrófagos infectados alcanzan órganos y tejidos hematopoyéticos (hígado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, etc.). La mayoría de las infecciones son asintomáticas, aunque algunos pacientes desarrollan leishmaniasis visceral clínica. La desnutrición y la inmunosupresión, en particular la infección por VIH, predisponen a la enfermedad clínica. El

período de incubación usualmente es entre 2 semanas y 2 meses. La leishmaniasis visceral puede ser endémica, esporádica o epidémica. En las zonas donde es endémica, la leishmaniasis visceral tiende a ser crónica y afecta especialmente a los niños y adultos jóvenes. La enfermedad se caracteriza por fiebre crónica, hepatoesplenomegalia, adenopatías y pérdida de peso. Se produce pancitopenia y una hipergammaglobulinemia policlonal. El oscurecimiento de la piel de la cara, manos, pies y abdomen se encuentra típicamente en la India (el nombre hindi, kala-azar, significa "fiebre negra" o "fiebre mortal"). Los signos de desnutrición se desarrollan a medida que avanza la enfermedad. Las infecciones intercurrentes son frecuentes.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de laboratorio es necesario para confirmar la sospecha clínica de leishmaniasis. Se basa en la visualización del parásito o su material genético (ADN y ARN), ya sea a partir de extendidos (frotis) o cultivos del material obtenido de la lesión cutánea o mucosa (para los casos de leishmaniasis cutánea y mucosa) o del material obtenido a partir de aspirado o biopsias de médula ósea, hígado o bazo (en el caso de leishmaniasis visceral).

Sin embargo, en algunos casos de leishmaniasis mucosa o visceral no siempre es posible visualizar o aislar el parásito y, por ello, el diagnóstico puede ser clínico y estar ayudado por la presencia de anticuerpos específicos contra *Leishmania* spp.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la leishmaniasis depende de varios factores, como la forma de la enfermedad, las afecciones concurrentes, la especie del parásito y la ubicación geográfica.

- En muchas ocasiones, la leishmaniasis cutánea se resuelve clínicamente sin tratamiento y no en todos los pacientes que se someten a tratamiento se produce la erradicación parasitaria. Los beneficios del tratamiento incluyen una curación más rápida de las lesiones cutáneas, menor probabilidad de recurrencia, disminución de la gravedad de las cicatrices y un menor riesgo de diseminación de la infección. En general, se recomienda terapia local para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea sin complicaciones (antimoniales pentavalentes o paromomicina tópica). En caso de complicación local o afectación mucosa se prefiere la terapia sistémica ya sea oral con azoles o miltefosina, o intravenosa con antimoniales pentavalentes, anfotericina B liposomal o pentamidina. Se acepta el uso de tratamientos locales intralesionales o termoterapia para la leishmaniasis cutánea localizada.
- Los agentes con actividad contra la leishmaniasis visceral incluyen anfotericina B, fármacos antimoniales pentavalentes, paromomicina y miltefosina. La anfotericina liposomal tiene la mayor eficacia terapéutica y el perfil de seguridad más favorable para el tratamiento de la LV. Aunque existen vacunas contra la leishmaniasis canina con un alto nivel de eficacia, no hay vacunas eficaces contra la enfermedad en humanos ni tampoco regímenes farmacológicos profilácticos. La prevención y el control de la leishmaniasis requieren una combinación de estrategias de intervención, dado que la transmisión se produce en un sistema biológico complejo que engloba el reservorio humano o animal, el parásito y el flebótomo vector. Las principales estrategias son por tanto el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano y eficaz, la lucha antivectorial y el control de los reservorios animales.

BIBLIOGRAFÍA

- Aronson N, Herwaldt BL, Libman M, et al. Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis: Clinical

Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Clin Infect Dis 2016; 63:e202.

- Control of the leishmaniasis: report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010.
- Croft S. L., Buffet P. A. Leishmaniasis, Capítulo 356. En Cecil y Goldman, Tratado de Medicina Interna, 24ª Edición. Elsevier, 2013. p. 2030-2035.
- Velez Bernal I. D., Robledo Restrepo S. M., Muskus López C., Leishmaniasis, Capítulo 2.2., Experto Universitario de Medicina Tropical, Editorial Médica Panamericana, 2020.
- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>